

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	高血壓 Hypertension				
	編號	制定者	公布日期	修正日期	檢閱日期
	A31000-Q03-W-B08	CCU 林炳蓁	98 年 05 月 31 日	115 年 01 月 06 日	
	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
	第 3.7 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解高血壓的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與護理措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

血壓標準為收縮壓 120mmHg，舒張壓 80mmHg。但高血壓標準則依據不同機構有不同定義，衛福部及美國心臟協會皆為『130/80mmHg』，世界衛生組織則為『140/90mmHg』。

（二）症狀

大部分的高血壓病人均無症狀，較嚴重者可出現頭痛，此通常於清晨起床後出現於頭枕部。其他相關的症狀包括暈眩、心悸、流鼻血、血尿等。視網膜發生病變時可出現視力模糊，視野缺陷。惡性高血壓通常會有下列症狀：視覺障礙、噁心及嘔吐、昏倒、暫時癱瘓、嚴重頭痛、意識不清、心衰竭症狀、心絞痛（因為動脈硬化或肥厚的心肌增加需氧量）。

（三）常見檢查

高血壓的例行檢查尚包括檢驗尿中的蛋白質、血球及血糖，看有無血尿、蛋白尿、檢驗血中的肌酐酸及尿素氮(Cr 及 BUN)、鉀離子濃度（可作為使用利尿劑前的基

主題名稱	高血壓	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B08	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	2/7

準質、且亦可篩檢 primary aldosteronism)、血糖、尿酸值、鈣離子濃度、膽固醇及三酸甘油酯濃度（可評估發生粥狀血管硬化的可能性）。

（四）常見治療

1.非藥物治療

應該鼓勵所有的高血壓病人接受非藥物治療，包括肥胖病人應減輕體重，停止吸煙，減少攝取脂肪及膽固醇，經常運動（如散步、游泳），適度的限制鹽分攝取等。少量的酒精（每天 360ml 的啤酒）雖可能減少心臟血管疾病的發生，然而大量的酒精確有升壓的效果，應該避免。此外，適度調適生活中的壓力亦有助於血壓的控制。

2.藥物治療

- (1)利尿劑：減少血循環量，此類的藥物可減少腎臟對水分的再吸收，如果單獨使用利尿劑對於 50%的病人有效。它特別能降低收縮壓。尤其對老年人來說，利尿劑是一個特別有效的降血壓藥物。
- (2)ACE 抑制劑：目前為第一線用藥。單獨使用本藥的成功率約為 40-50%，如果和低劑量的利尿劑或是鈣離子阻斷劑合用的話，ACE 抑制劑可以成功地控制 70%病人的血壓。
- (3) β -阻斷劑： β -腎上腺阻斷劑大約可以有效降低 50 到 60%的病人血壓，尤其是 renin-angiotensin 系統被活化的病人。所有的 β -阻斷劑都會使左心室功能不良更加惡化；它們會減少心輸出量、而且導致性無能。
- (4)鈣阻斷劑：在所有降血壓藥物中，鈣離子阻斷劑是最容易為病人所接受的一種。如果單獨使用，它對 60 到 70%的病人都有效（不論種族或年齡）。將鈣離子阻斷劑和 β -阻斷劑（例如：diltiazem、verapamil）合用時，一定要小心避免造成過度的心搏過慢或心律阻斷。其他的副作用包括了週邊水腫和嚴重的便秘。
- (5) α -阻斷劑：作用在血管突觸後的 α -阻斷劑可以擴張動脈和靜脈。注意有無姿勢性低血壓副作用，尤其是在給第一次劑量之後。

主題名稱	高血壓	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B08	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	3/7

(6)中樞作用藥物：作用是刺激中樞 $\alpha 1$ -腎上腺受體，可以減少週邊的交感神經輸出。

(7)動脈直接擴張劑：像 hydralazine 和 minoxidil 一類的動脈擴張劑可以鬆弛血管的平滑肌，從而降低血壓。

(8)混合治療：混合使用不同種類的降血壓藥物。

(五) 護理問題

- 1.低心輸出量/與周邊血管阻力增加有關。
- 2.體液容積太多/與鈉攝取過多、低心輸出量有關。
- 3.尋求（特定的）健康協助/與高血壓的控制有關。
- 4.易受傷害/與高血壓藥物副作用有關。

(六) 護理措施

- 1.低心輸出量/與周邊血管阻力增加有關。
 - (1)監測並記錄意識變化、心跳速率及節律、呼吸、血壓等。
 - (2)監測及記錄每日輸入及輸出量。
 - (3)指導病人及家屬減低心臟的工作負荷。
 - (4)監測實驗室檢查數值的變化。
- 2.體液容積太多/與鈉攝取過多、低心輸出量有關。
 - (1)監測血清尿素氮、肌酸酐、電解質、血色素、血比容及尿比重。
 - (2)評估體液存留的症狀、水腫及腹水。
 - (3)指導病人及家屬飲食中需限制鈉的攝取。
 - (4)指導病人及家屬遵從治療的重要性，包括飲食的限制及藥物的服用。
- 3.尋求（特定的）健康協助/與高血壓的控制有關。
 - (1)評估病人對疾病的認知與學習動機，予以澄清與計畫護理指導內容。
 - (2)指導病人控制高血壓的重要性，與測量、記錄血壓方法。
 - (3)指導病人按時服藥的重要、藥物之用法。
 - (4)指導病人調整生活型態之益處與方法。

主題名稱	高血壓	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B08	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	4/7

4.易受傷害/與高血壓藥物副作用有關。

(1)密切監測血壓（每天測量）與視力的變化。

(2)指導病人按時服藥且不可自行調整劑量。

(3)服用高血壓藥後不宜長時間站立，以避免發生姿勢性低血壓，若有頭暈的感覺，應立即躺下。

(4)改變姿勢時應緩慢移動，由平躺、坐起在站立，不突然改變姿勢。

(5)避免伐氏操作法(Valsalva's Maneuver)，不突然用力，避免便秘。

(6)評估並維持安全之居家環境，避免視力改變所造成的危險。

(7)服用排鉀利尿劑時，應定期監測鉀離子濃度，並注意有無低血鉀症狀，如肌肉無力。

（七）衛教措施

給予「高血壓患者注意事項」之衛教單張，重點如下：

- 1.生活調節：不吸煙、不要酗酒、保持理想體重、進行適量及有恆的運動、注意均衡飲食、少吃高脂肪、高膽固醇和太鹹的食物。
- 2.藥物治療：定時定量服藥、長期服藥、定期檢查。
- 3.服用降血壓藥物需注意事項：服藥後如有不適，應回診請教醫師。藥物不可與酒精飲品同服。未經醫師同意，不要胡亂服食其他藥物。應在藥物存量還足夠數天之用時便複診，切勿到最後一刻才複診。如出外旅遊，要配額足夠的藥物使用。

（八）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

主題名稱	高血壓	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B08	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	5/7

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 謝春蘭、高碧霞、蔡文惠、謝玉娟、吳玉玲、歐育珊等(2019)・急重症護理學・永大。
- (二) 葉宇軒、陳岳陞、彭子駿、盧冠錡、林暉凱、陳民虹 (2025)・從血管內皮細胞角度解析高血壓的成因、預防與治療・澄清醫護管理雜誌，21(3)，42-53。
- (三) 汪文華、劉傳捷、吳淑芳、陳孟淇、李梅琛、黃秀麗 (2020)・高血壓病人心理健康、自我管理與生活品質之相關性・北市醫學雜誌，1-13。
- (四) 健康指南(2024，7 月 1 日)・高血壓標準?低血壓標準?WHO 及衛生署修訂最新的血壓標準介紹。<https://takecareof.com.tw/articles/blood-pressure-standard/>

七、附件

(略)

主題名稱	高血壓	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B08	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定。	98 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
101.08.31	2.1	1.醫護部改護理部。 2.護理措施部份內容修正。	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.06.02	3.1	更新第六項參考資料。	104 年 06 月 02 日 護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.2	1. 新增參考文獻資料於內文中。 2. 第六項參考資料增刪及修訂。	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.3	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。
108.09.23	3.4	第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.07	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	高血壓	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B08	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
111.11.08	3.5	1. NANDA 護理診斷更新為護理問題。 2. 內文參考文獻引用刪除。 3. 增加第六項參考資料。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.10.26	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.17	3.6	1. 修訂高血壓定義。 2. 新增第六項參考資料。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過； 113 年 12 月 11 日護理長會議通過；113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
115.01.06	3.7	第六項參考資料修訂。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過； 114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。